

Estabilización, reposicionamiento y plano posterior

Tema 11 · Férulas oclusales

Qué es una férula

Aparato removible, generalmente de acrílico duro, que cubre las superficies oclusales de una arcada. Su función es **modificar temporalmente** la relación oclusal y distribuir las fuerzas.

Su mayor virtud es que es **reversible**. Por eso es la primera línea de tratamiento antes de cualquier terapia irreversible: si no funciona, se retira y el paciente queda como estaba.

Objetivos: proteger estructuras, relajar musculatura, reposicionar la mandíbula y servir como herramienta **diagnóstica**.

Férula de estabilización

Es la más usada y la más versátil. También llamada miorrelajante o tipo Michigan.

Características:

- Cobertura **total** de la arcada
- Contactos **uniformes y simultáneos** de todos los dientes antagonistas en relación céntrica
- **Guía anterior** que desocluye los posteriores en movimientos excéntricos
- **Guía canina** en lateralidad
- Superficie plana y lisa

Indicaciones: bruxismo, dolor muscular, protección de restauraciones extensas. Uso habitual nocturno.

Férula de reposicionamiento anterior

Reposiciona la mandíbula **hacia adelante** para recapturar el disco desplazado y mantener una relación cóndilo-disco más favorable.

Indicación principal: desplazamiento discal **con reducción**, especialmente cuando hay dolor o el clic es reciente.

Advertencias que debes tener presentes:

- Uso **limitado en tiempo**, con controles frecuentes
- El uso prolongado puede producir **mordida abierta posterior** irreversible
- No es para todos los pacientes con clic: muchos clics asintomáticos no requieren tratamiento

Es la férula que más vigilancia exige.

Plano de mordida posterior

Cubre únicamente los **dientes posteriores**, habitualmente con dos segmentos unidos por una barra lingual.

Indicaciones: casos que requieren cambios importantes de dimensión vertical o de posición mandibular, y algunos cuadros de mordida profunda severa.

Riesgo importante: al no cubrir los anteriores, permite la **extrusión** de los dientes no cubiertos. Es de uso **corto y muy controlado**. No es una férula de uso prolongado.

Plano de mordida anterior

Cubre solo los dientes anteriores. Produce desoclusión posterior inmediata y relajación muscular rápida, y por eso también se usa como desprogramador.

El mismo riesgo, invertido: permite **extrusión de los posteriores** y puede generar mordida abierta si se usa de forma prolongada.

Regla práctica: cualquier férula de cobertura **parcial** es de uso corto y con controles. Solo las de cobertura **total** admiten uso prolongado.

Criterios de una férula bien hecha

- **Retención** adecuada: se sostiene sola, entra y sale sin forzar
 - **Estabilidad**: no bascula al presionar de un lado
 - **Contactos puntiformes uniformes** en todos los antagonistas
 - **Guía anterior** que desocluye posteriores en protrusiva
 - **Guía canina** que desocluye el resto en lateralidad
 - Superficie **lisa y pulida**, sin filos
 - Grosor mínimo compatible con resistencia, habitualmente 2 a 3 mm en posteriores
- El ajuste se verifica con papel de articular y se repite en los controles: la férula cambia con el uso.

Manejo seguro del acrílico

El monómero de metilmetacrilato es **volátil, inflamable e irritante** para vía respiratoria, piel y mucosas. Además hay riesgo de sensibilización con la exposición repetida.

Medidas:

- Trabajar en área **ventilada**
- **Guantes** y lentes de protección
- No inhalar los vapores directamente
- Mantener alejado de fuentes de calor
- Frascos **cerrados** cuando no se usan
- Curado en olla de presión, alrededor de 20 minutos

La polimerización es **exotérmica**: la pieza se calienta. Nunca se prueba en boca durante el fraguado.

Lo que una férula no hace

Es importante que se lo expliques al paciente desde el inicio:

- **No cura el bruxismo.** El paciente sigue apretando: lo que hace es proteger y distribuir la fuerza
- **No corrige la maloclusión**
- **No sustituye** el diagnóstico ni el manejo de la causa de fondo

Si el paciente aprieta por estrés o por un trastorno del sueño y eso no se atiende, la férula protege los dientes pero el problema sigue. Es protección y diagnóstico, no curación.

Este material también está disponible en la plataforma, con ejercicios de autoevaluación por niveles y el asistente académico. dentipedia.dentilike.com.mx